

IMC - 30.19

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA
NS

RICARDO TEIXEIRA DE CARVALHO

IDADE: 61 a PESO: 106 ALTURA: 182 PROFISSÃO: Engenheiro
SINTOMAS: Boca seca / esquecido Dormir de lado
QUEIXAS: Camarão / sonolento / edema leve mm II.

MEDICAMENTOS:

(cirurgia de refluxo)

MÉDICO: Dr. Vitor

MARCAPASSO: () S ☒ N / COMPANHEIRO(A) USA MARCAPASSO: () S ☒ N

EXERCÍCIO FÍSICO: 4 a 5x semana

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: S ALMOÇO: S LANCHE: — JANTAR: S

HORA QUE DORME: 00:00 HORA QUE ACORDA: 08:00

COCHILLO () SIM ☒ NÃO DORME ACOMPANHADO () SIM () NÃO ☒ EVENTUAL

BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA ☒ NÃO

FUMO () SIM () MAÇO/DIA ☒ NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO: 1x

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: globosa CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO: 41

OVERLAP: não MALLAMPATI: IV IAH: 49.9% SPO2: 82%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS:

CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA

HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: não

IMC: Desp = 31.9

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (N) CARDÍACA

(S) ORTOPÉDICA (S) NEUROLÓGICA () OUTROS { Dor quadril / ombro
27/06 Avaliação espôlio calcâneo
24

08/07/24 P = 7.0 → Rinite nariz entupido
IAH = 1.7 e/h → não consegue dormir
m. de uso: 7hr de lado.
Fuga = 13 lpm Jua

26/07 P = 7.2 cmH₂O
24 IAH = 0.9 e/h
m. de uso: 6h 19'
Bem adaptado Jua.

13/09 P = 6 cmH₂O - 7.4 cmH₂O
24 IAH = 1.5 e/h

08/11/24 P = 7.2 cmH₂O
IAH = 1.3 e/h aumento alívio pl 2
m. de uso: 5h 40m
fuga: 0.7 l/m
Natacha

Nome: RICARDO TEIXEIRA DE CARVALHO
Data de Nascimento: 16-5-1963
IMC: 30,19
Sexo: Masculino
Data do exame: 26-04-2023

Peso: 100 kg
Altura: 1,82 m
Médico: DR. CARLOS HENRIQUE DE
LABINAS OLIVEIRA
Medicamentos:
Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 26-04-2023, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 505,0 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 86,5 e 74,0 minutos. O tempo total de sono foi de 390,5 min, eficiência de 77,3% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,6%; estágio N2: 61,1%; estágio N3: 16,0%; sono REM: 20,4%. O índice de despertares foi de 27,9/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 49,9/hora, sendo 78 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 133 hipopnéias. A SpO2 média foi de 94% e a mínima de 82%, permanecendo 0,9% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 51 - 89 bpm e NREM de 50 - 75 bpm.

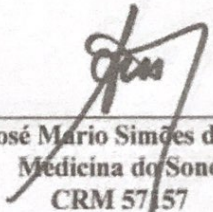
CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (5), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM normal e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 49,9/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=82%);
5. latência para o sono aumentada e latência para o sono REM diminuída;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco durante o sono.

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau acentuado.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

Nome: RICARDO TEIXEIRA DE CARVALHO

Data de Nascimento: 16-5-1963

IMC: 30,19

Sexo: Masculino

Data do exame: 21-05-2023

Peso: 100 kg

Altura: 1,82 m

Médico: DR. CARLOS HENRIQUE LABINAS
DE OLIVEIRA

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia para titulação de CPAP

Exame realizado na noite de 21-05-2023, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 498,0 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 30,5 e 80,5 minutos. O tempo total de sono foi de 418,5 min, eficiência de 84,0% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 1,8%; estágio N2: 53,2%; estágio N3: 20,4%; sono REM: 24,6%. O índice de despertares foi de 3,9/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 6,6/hora, sendo 2 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 44 hipopnéias. A SpO2 média foi de 94% e a mínima de 90%, permanecendo 0,0% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 59 - 83 bpm e NREM de 58 - 91 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (3), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM e porcentagem dos estágios do sono NREM dentro da normalidade;
3. latência para o sono ligeiramente aumentada e latência para o sono REM diminuída;
4. número de despertares breves normal;
5. presença de atividade em EMG de queixo;
6. registro de ronco durante o sono.

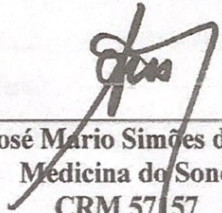
Exame polissonográfico para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 4,0 cmH2O.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157